Dolor de muela: qué le está pasando a tu pulpa

Guía para pacientes · Clasificación diagnóstica actual en endodoncia · Qué se siente en cada etapa · Qué hacer mientras llegas al dentista — Dr. Nicolás Guzmán, Cirujano Dentista · Concepción

1. ¿Qué es la pulpa y por qué duele tanto?

Dentro de cada diente hay un tejido vivo, la **pulpa**, con nervios y vasos sanguíneos. Cuando una caries profunda, una fractura, un golpe o una restauración filtrada irrita la pulpa, esta se **inflama**. En cualquier parte del cuerpo, la inflamación aumenta el volumen del tejido. Pero la pulpa está encerrada en paredes duras de dentina que no se pueden expandir: la presión sube dentro del diente y comprime los nervios. Por eso el dolor puede ser tan intenso, pulsátil, y muchas veces peor de noche o al acostarse.

Que duela o no duela **no** indica por sí solo qué tan grave está el diente: hay pulpas muy dañadas que no duelen, y pulpas que duelen mucho pero aún se pueden conservar. Por eso el diagnóstico lo hace un profesional con examen clínico, pruebas de sensibilidad (frío, percusión) y radiografía.

2. Cómo se clasifica hoy: la terminología de la Asociación Americana de Endodoncia (AAE)

El estándar más usado en el mundo es la terminología de consenso de la AAE, que siempre combina **dos diagnósticos**: uno de la pulpa (dentro del diente) y otro de los tejidos alrededor de la punta de la raíz (diagnóstico apical). La guía europea S3 de la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE, 2023) trabaja sobre los mismos conceptos. Existen propuestas más nuevas que gradúan la pulpitis por severidad (leve, moderada, severa; Wolters 2017), útiles en investigación, pero en estudios de validación la clasificación AAE mostró mayor acuerdo entre clínicos.

2.1 Diagnóstico pulpar — qué sientes en cada etapa

Diagnóstico	Qué siente el paciente	Qué significa	Manejo habitual
Pulpa normal	Nada. El frío se siente un instante y se va.	Pulpa sana.	Controles preventivos.
Pulpitis reversible	Dolor agudo y breve con frío, dulce o aire, que desaparece en segundos al retirar el estímulo. Sin dolor espontáneo.	Inflamación que puede sanar si se elimina la causa.	Eliminar caries y restaurar, o proteger la dentina expuesta. Revaluar después.
Pulpitis irreversible sintomática	Dolor intenso que **se queda** después del frío o calor (habitualmente 30 seg o más), dolor espontáneo, nocturno, pulsátil; puede irradiarse al oído, sien o mandíbula y costar ubicar el diente.	La pulpa inflamada ya no se recupera sola.	Endodoncia. En casos seleccionados, pulpotomía (conservar parte de la pulpa viva).
Pulpitis irreversible asintomática	Sin dolor. Suele detectarse por una caries muy profunda o tras un trauma.	Daño importante sin síntomas.	Igual que la sintomática; según hallazgos clínicos.
Necrosis pulpar	El diente ya no responde al frío. El dolor puede **desaparecer** (engañoso). A veces el diente se oscurece.	La pulpa murió; puede infectarse.	Endodoncia o extracción, según si el diente es restaurable.
Previamente tratado / tratamiento iniciado	Variable: desde nada hasta dolor al morder.	Diente con endodoncia o tratamiento parcial previo.	Evaluar; puede requerir retratamiento.

2.2 Diagnóstico apical — cuando el problema sale de la raíz

Diagnóstico	Qué siente el paciente	Qué significa
Tejidos apicales normales	No duele al morder ni al golpear suavemente el diente.	El hueso alrededor de la raíz está sano.
Periodontitis apical sintomática	Dolor al morder o al tocar el diente; sensación de diente "alto" o "largo".	Inflamación alrededor de la punta de la raíz.
Periodontitis apical asintomática	Sin síntomas. Se ve como una zona oscura en la radiografía.	Lesión en el hueso, generalmente por una pulpa necrótica.
Absceso apical agudo	Dolor intenso, hinchazón, a veces fiebre o malestar general.	Infección con pus que puede extenderse. **Atención inmediata.**
Absceso apical crónico	Poco o nada de dolor; un "granito" en la encía que bota pus (fístula).	Infección de larga data que drena.
Osteítis condensante	Sin síntomas.	Hallazgo radiográfico: reacción del hueso a una inflamación de baja intensidad.

3. Hasta dónde puede llegar el daño

Zona	Qué ocurre	Por qué importa
Diente (esmalte y dentina)	La caries avanza lento en el esmalte y más rápido en la dentina.	Por fuera puede verse pequeña aunque esté cerca de la pulpa.
Pulpa	Inflamación (pulpitis) que puede terminar en necrosis.	Mientras antes se trate, más pulpa viva se puede conservar.
Hueso alrededor de la raíz	Inflamación o infección apical, lesión ósea, absceso.	Puede doler al morder o no dar síntomas por meses.
Cara y cuello	Rara vez, la infección se disemina a los espacios de la cara.	Hinchazón de cara, fiebre, dificultad para tragar o respirar = **urgencia hospitalaria.**

4. Qué hacer mientras llegas al dentista

La guía 2024 de la Asociación Dental Americana (ADA) para el manejo **temporal** del dolor de muela, cuando el tratamiento definitivo no está disponible de inmediato, propone como primera opción un **antiinflamatorio no esteroidal (AINE)**, como ibuprofeno, **solo o combinado** con paracetamol, y deja los opioides solo para casos excepcionales. Es una recomendación condicional, con certeza de evidencia baja, pensada para aguantar hasta la atención (idealmente dentro de 2 a 3 días), no para reemplazarla.

Lo que sí	Lo que no
Antiinflamatorio de venta libre (p. ej., ibuprofeno), solo o con paracetamol, **respetando las indicaciones del envase** y si no tienes contraindicaciones (úlcera o problemas gástricos, enfermedad renal, embarazo, uso de anticoagulantes, alergia o asma por AINEs).	Poner una aspirina u otra pastilla sobre la encía: quema la mucosa.
Dormir con la cabeza un poco más alta.	Aplicar calor en la cara.
Evitar estímulos que gatillan el dolor (muy frío, muy caliente, masticar con ese lado).	Tomar antibióticos por tu cuenta: la ADA (2019) no los recomienda para el dolor de pulpitis; no quitan el dolor y favorecen la resistencia bacteriana.

Pedir hora lo antes posible: el analgésico compra horas, no resuelve la causa.	Combinar varios antiinflamatorios distintos entre sí, o superar las dosis del envase.

Acude de inmediato a un servicio de urgencia si tienes: hinchazón de la cara o el cuello, fiebre, dificultad para tragar, abrir la boca o respirar, o te sientes muy decaído. Estos signos indican que la infección podría estar extendiéndose y requieren atención el mismo día.

Dato Chile: la urgencia odontológica ambulatoria es una garantía GES (MINSAL); las pulpitis son una de sus consultas más frecuentes.

5. Opciones de tratamiento: qué sí hacen y qué no

Opción	Qué sí hace	Qué no hace
Analgésico / antiinflamatorio	Alivia el dolor por algunas horas mientras llegas a la atención.	No elimina la inflamación de la pulpa ni la infección.
Antibiótico (indicado por un profesional)	Útil cuando la infección se extiende (hinchazón difusa, fiebre) o en pacientes con condiciones de riesgo.	No quita el dolor de una pulpitis ni reemplaza el tratamiento del diente.
Pulpotomía (terapia pulpar vital)	Retira solo la pulpa inflamada y conserva la sana. La AAE (2021) y la guía S3 europea de caries profunda la aceptan como alternativa en pulpitis irreversible seleccionada.	No está indicada si la pulpa está necrótica o hay lesión en el hueso de la raíz; depende de lo que se observe durante el procedimiento.
Endodoncia (tratamiento de conducto)	Elimina la pulpa inflamada o infectada, desinfecta y sella los conductos: elimina el dolor de origen pulpar y salva el diente.	No deja el diente "terminado": luego necesita una restauración adecuada (resina, incrustación o corona) para no fracturarse.
Extracción	Elimina el foco de dolor e infección cuando el diente no se puede restaurar.	Pierdes el diente: los vecinos se mueven y el hueso se reabsorbe; conviene planificar su reemplazo.

6. Recomendaciones generales

• Un dolor que se queda después del frío, que aparece solo o que te despierta en la noche **no es normal**: consulta pronto.

• Si el dolor "desapareció" solo después de días de dolor fuerte, no significa que se curó: puede ser necrosis. Revísalo igual.

• Las caries profundas detectadas a tiempo permiten tratamientos más simples y conservar la pulpa viva.

• Controles cada 6 meses, cepillado con pasta con flúor dos veces al día e hilo dental o cepillo interdental diario.

• Las restauraciones antiguas también se controlan: una filtración puede avanzar sin dolor.

Referencias

1. American Association of Endodontists. AAE Consensus Conference Recommended Diagnostic Terminology. J Endod. 2009;35(12):1634.
2. American Association of Endodontists. Glossary of Endodontic Terms. 10th ed. Chicago: AAE; 2020.
3. Duncan HF, Kirkevang LL, Peters OA, et al. Treatment of pulpal and apical disease: The European Society of Endodontology (ESE) S3-level clinical practice guideline. Int Endod J. 2023;56(Suppl 3):238-295. doi:10.1111/iej.13974
4. Schwendicke F, et al. Deep caries management: EFCD-ESE-ORCA S3-level clinical practice guideline. Clin Oral Investig. 2025 / Int Endod J. 2026. doi:10.1111/iej.70132
5. AAE Special Committee on Vital Pulp Therapy. AAE Position Statement on Vital Pulp Therapy. J Endod. 2021;47(9):1340-1344.
6. Carrasco-Labra A, Polk DE, Urquhart O, et al. Evidence-based clinical practice guideline for the pharmacologic management of acute dental pain in adolescents, adults, and older adults. J Am Dent Assoc. 2024;155(2):102-117.
7. American Dental Association, University of Pittsburgh, University of Pennsylvania. Chairside Guide: Temporary pharmacologic management of acute dental pain — toothache in adolescents, adults, and older adults with no immediate access to definitive dental treatment. 2024.
8. Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, et al. Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling. J Am Dent Assoc. 2019;150(11):906-921.
9. Wolters WJ, Duncan HF, Tomson PL, et al. Minimally invasive endodontics: a new diagnostic system for assessing pulpitis and subsequent treatment needs. Int Endod J. 2017;50(9):825-829. doi:10.1111/iej.12793
10. Karrar RN, et al. Clinical validation of a proposed diagnostic classification for pulpitis. Int Endod J. 2025. doi:10.1111/iej.14254
11. Careddu R, Duncan HF. A prospective clinical study investigating the effectiveness of partial pulpotomy after relating preoperative symptoms to a new and established classification of pulpitis. Int Endod J. 2021. doi:10.1111/iej.13629
12. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline for use of vital pulp therapy in permanent teeth. Pediatr Dent. 2025;47(5).
13. Ministerio de Salud de Chile. Guía Clínica Urgencias Odontológicas Ambulatorias. 2.ª ed. Santiago: MINSAL; 2011.

Nota: *esta guía es material educativo general y no reemplaza la evaluación clínica. Los medicamentos mencionados deben usarse según las indicaciones del envase o de un profesional de la salud, considerando tus antecedentes médicos. Ante signos de urgencia, acude a un servicio de urgencia.*

¿Te duele una muela? No esperes a que sea insoportable.

Escríbeme por WhatsApp y evaluamos tu caso: wa.link/tu8qmu